

Роль молока в лечебно профилактическом питании

Наверняка всем известно выражение «молоко дают за вредность», но задумывались ли мы над историей происхождения данного выражения? Все началось в 1918 году, когда В.И. Ленин особым Декретом утвердил выдачу молока голодающим рабочим Путиловского завода в Петрограде. Выдача молока была обусловлена необходимостью накормить голодных рабочих, трудящихся в сложных условиях. Через год на многих производствах, связанных с опасностью профессионального отравления стали выдавать так называемые «спецжиры» – молоко, масло, жиры, которые имели не столько профилактическое значение, а использовались как продукты дополнительного питания.

В 1922 году в Кодексе законов о труде РСФСР появилась статья,

 **443** (<https://i0.wp.com/trudohrana.org/wp-content/uploads/2015/05/443.png>)

закрепляющая выдачу рабочим, занятым «в производствах, связанных с опасностью профессионального отравления, в качестве противоядия жиров или нейтрализующих веществ по спискам и в размере, устанавливаемым Народным Комиссариатом труда». В качестве нейтрализующих веществ использовались содовая вода, молоко, сахар, жир и др. Были определены категории рабочих, которым вследствие вредности работы предприятие выдавало в качестве противоядия по одной бутылке молока в сутки (в дальнейшем установлена дневная норма 0,615л).

В 1926 году была запрещена замена молока другими продуктами. Таким образом, **именно за молоко закрепилось** значение «универсального антитоксического продукта при работе во вредных условиях воздействия разнообразных промышленных веществ» (Г.И. Бондарев с соавт., 1980; А.Н. Сысин с соавт., 1929; З.Х. Диланян, 1958; А.Ю. Грубина с соавт., 1959; В.А. Доценко с соавт., 1987).

И только лишь в 1968 году Минздравом СССР было введено понятие «другие равноценные пищевые продукты», которые допускалось использовать на местах взамен молока. В качестве таких продуктов были определены кислое молоко, колибактерин при работе с антибиотиками и пектин в виде мармелада или концентрата пектина с чаем при работе со свинцом и его соединениями. В последнем случае молоко выдавать не рекомендовалось, так как было установлено, что оно отрицательно влияет на течение свинцовой интоксикации.

Дальнейшее развитие промышленности и данные научных исследований показали, что молоко не может обеспечить полноценный протекторный эффект. В связи с этим в 1991 году Минздрав СССР считал возможным замену молока продуктами животного происхождения (кисломолочные продукты, творог, сыр, мясо говядина, рыба нежирных сортов, яйца).

С распадом СССР в Республике Беларусь был утвержден ряд документов, определяющих порядок обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников. Согласно **статье 225** Трудового кодекса Республики Беларусь работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами.

Так чем же все-таки полезно молоко и надо ли применять его при работе во вредных (опасных) условиях труда? Пищевая и биологическая ценность свежего коровьего молока заключается в оптимальной сбалансированности его компонентов. Молоко содержит более двухсот различных органических и минеральных веществ и многие необходимые для человеческого организма



питательные и биологически активные вещества. Молоко в объеме 0,5 литра обеспечивает 15% суточной потребности человека в белках, усвояемость которых составляет 80-98%. Сывороточные белки молока являются носителями иммуноглобулинов, которые воздействуют на болезнетворные микроорганизмы и вирусы. Лактоферрин и другой белок – лизоцим, относящийся к ферментам молока, обладают антибактериальными свойствами. К сожалению, после тепловой обработки молоко теряет часть полезных свойств.

Важной характеристикой детоксикационной способности продукта является содержание в нем глутатиона – одного из основных серосодержащих антиоксидантов. Считается, что в сутки человек должен получать не меньше 1 г глутатиона. Содержание глутатиона в молоке составляет 164 мкмоль/л. Но даже сам фактор наличия в молоке пусть и незначительного количества глутатиона не обеспечивает его детоксикационную активность, так как в молоке содержится очень высокий уровень глутатион-реактивных веществ, подавляющих его активность. **Проведенные исследования свидетельствуют, что в молоке, прошедшем обработку, нет глутатиона, но содержатся вещества, подавляющие активность глутатиона, поступающего в организм с другими продуктами или образующегося в нем.**

Фактически в молоке не выявлено специфических биологически активных веществ, обеспечивающих снижение негативного влияния неблагоприятных факторов производственной среды на организм. Более того, есть факторы, препятствующие проявлению детоксикационной активности другими продуктами. Следует также учитывать наличие ряда противопоказаний для применения молока, в числе которых: отравление ядами, растворимыми в жирах, отравление свинцом, углеродами и их галопродуктами, наличие лактазной недостаточности, аллергии к молоку, ряд заболеваний, при которых ограничен прием молока, и другие.

С 25 июля 2014 г. вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2014 г. № 491 (<http://trudohrana.org/postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-21-maya-2014-g-491/>) «Об утверждении Положения о порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (<http://trudohrana.org/postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-21-maya-2014-g-491/>). Признано утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 1386 «О бесплатном обеспечении лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». (<http://trudohrana.org/postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-23-oktyabrya-2007-g-1386/>) Следует обратить внимание, что утвержденное Положение распространяется на нанимателей независимо от их форм собственности и организационноправовых форм.

Бесплатное обеспечение лечебнопрофилактическим питанием работников осуществляется нанимателями в соответствии с утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения:

- перечнем производств, работ, профессий и должностей, дающих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания;
- рационами лечебно-профилактического питания, выдаваемого бесплатно работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Руководитель организации (его заместитель, уполномоченный согласно системе управления охраной труда) в соответствии с перечнем определяет конкретные профессии и должности, дающие право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания.

Положением определены критерии, по которым определяются работники, подлежащие обеспечению лечебно-профилактическим питанием. **Так, лечебнопрофилактическим питанием обеспечиваются работники, фактически занятые не менее половины рабочего дня (смены):**

- на производствах, работах, по профессиям или в должностях, предусмотренных в перечне;



(https://v



(https://v



(https://t



(https://c



(https://v

- чисткой, обслуживанием, ремонтом, демонтажем или консервацией оборудования (подготовкой к этим операциям) на производствах, работники которых получают лечебно-профилактическое питание. Данные работники обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием независимо от того, предусмотрена ли его выдача в структурном подразделении организации, в которое они приняты на работу;
- выполняющие строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы на производствах иных организаций, если работники этих производств, включая занятых на ремонтных работах, получают лечебно-профилактическое питание.

В организациях, работники которых получают лечебно-профилактическое питание, на каждый день составляются меню-раскладки, включающие продукты, предусмотренные рационами.

В рационе, рассчитанном на один прием (день), допускаются отклонения показателей химического состава и энергетической ценности $\pm 10\%$ рациона и в расходовании продуктов, но в течение рабочей недели они должны быть использованы в полном объеме.

Готовые блюда, приготовленные на основе рациона, и (или) витаминные препараты выдаются разово перед началом рабочего дня (смены) независимо от его продолжительности в объектах общественного питания. Допускается выдача лечебно-профилактического питания в иное время, но не позднее чем в обеденный перерыв.

Необходимо иметь в виду, что выдача лечебно-профилактического питания за прошлое время и денежная компенсация за своевременно не полученное лечебно-профилактическое питание не производятся. Дополнительная бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов, а также пектинов работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание, не производится.

В служебных командировках или при разъездном характере работы работнику, имеющему право на бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, выплачивается денежная компенсация на его приобретение на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Текст постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2014 г. № 491 (<http://trudohrana.org/postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-21-maya-2014-g-491/>) «Об утверждении Положения о порядке предоставления и определения объемов компенсации в виде бесплатного обеспечения лечебнопрофилактическим питанием работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», перечень производств, профессий, должностей и работ, занятость на которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, рационы лечебнопрофилактического питания, выдаваемого бесплатно работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Читать на сайте: <http://trudohrana.org/rol-moloka-v-lechebno-profilakticheskom-pitanii/>
(<http://trudohrana.org/rol-moloka-v-lechebno-profilakticheskom-pitanii/>)

Язык Русский

Войдите (</ru/user/login?destination=node/144%23comment-form>), чтобы оставлять комментарии





Международный образовательный центр
«На Академической»

(https://rspch.by/ru/obrazovatelniy_centre_2023)

**СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ
ДИССЕРТАЦИЙ**

(http://rspch.by/ru/diss_council_2023)

**ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ,
СЕРТИФИКАЦИЯ,
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ**

(<https://certificate.by/>)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»



(https://rspch.by/ru/conf_health_environment_2025)



(<https://mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/opublikovan-plan-meroprijatij-k-godu->

[belorusskoj-zhenschiny-11622-2026/](https://mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/opublikovan-plan-meroprijatij-k-godu-belorusskoj-zhenschiny-11622-2026/))



(<https://eccis.org/thematic/72/2026/0>)



(<https://vk.com/rspch.by>)



(<https://www.facebook.com/rspch.by>)



(https://twitter.com/rspch_by)



(<https://ok.ru/rspch.by>)



(<https://www.instagram.com/rspch.by>)



(<https://rspch.by/ru/node/902>)

**МИНЗДРАВ ОТКРЫЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ
ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИЕМНУЮ**

@BY_MINZDRAV_BOT

**ЧАТ-БОТ —
ОПЕРАТИВНЫЙ
РЕСУРС ДЛЯ
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВА НА
ЭКСТРЕННУЮ
СИТУАЦИЮ!**

Ресурсом могут воспользоваться **КАК ПАЦИЕНТЫ, ТАК И МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ**. На все поступившие обоснованные конкретные заявления по вопросам оказания экстренной медицинской помощи, касающиеся спасения жизни пациента или медработника, мы отреагируем оперативно!

Чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение, не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему обращения в Минздрав. Главное — мы поможем исправить ситуацию только если есть четкие данные МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ВАШЕЙ ФАМИЛИИ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО, КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

(https://t.me/by_minzdrav_bot)



(https://vk.com/by_minzdrav_bot)



(https://www.facebook.com/by_minzdrav_bot)



(https://twitter.com/by_minzdrav_bot)



(https://t.me/by_minzdrav_bot)



(https://www.instagram.com/by_minzdrav_bot)



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ (<http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/>)



ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» (<http://rcheph.by>)



ПОРТАЛ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (<http://качество-услуг.бел/RatingPortal>)



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ (<http://mfa.gov.by/mulateral/sdg>)



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ (<http://nasb.gov.by>)



НИИ ГТЭВМ (СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ) (<http://certificate.by/>)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (<http://minzdrav.gov.by/>)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ (<http://pravo.by/>)



САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(<http://president.gov.by/>)

Контакты

220012, г. Минск,
ул. Академическая, 8

Телефон: + 375 17 347 73 70

Факс: + 375 17 272 33 45

e-mail: rspch@rspch.by

Телефон: + 375 17 360 49 61

+ 375 29 233 92 83

+ 375 29 193 92 83

e-mail: rspch@rspch.by

Способы оплаты

В нашем центре используются следующие способы оплаты:

Система расчетов "Ерип"

Реквизиты центра

Государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

Адрес: ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск

Тел.: + 375 17 351 08 03

Факс: + 375 17 215 19 78

e-mail: mail@rcheph.by

Банковские реквизиты:

р/с BY07AKBB36049625450095400000 (бюджет)

р/с BY24AKBB36329625450005400000 (внебюджет)

ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк»

УНП 100468797

ОКПО 055653565000

БИК АКBBBY2X

Адрес банка: ул. Воронянского, 7а, г. Минск



(<https://vk.com/rccheph>)



(<https://www.facebook.com/rccheph>)



(<https://twitter.com/rccheph>)



(<https://ok.ru/rccheph>)



(<https://www.instagram.com/rccheph>)

Вышестоящий государственный орган

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь.
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39.

Режим работы:

Начало работы - 9.00
Обеденный перерыв - 13.00 - 14.00
Окончание работы - 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: + 375 17 222 65 47 (Канцелярия),
Факс: + 375 17 222 46 27
e-mail: mzrb@belcmt.by (<mailto:mzrb@belcmt.by>)
Телефон «горячей линии»: **+ 375 17 222 70 80**

Copyright 2024 / НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии / Все права защищены



(<https://v>



(<https://v>



(<https://t>



(<https://c>



(<https://v>